



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

MESURER

& AMÉLIORER LA QUALITÉ

RAPPORT DE CERTIFICATION

AP-HM - HÔPITAL DE LA TIMONE

264 rue saint pierre
13385 Marseille



Validé par la HAS en Mai 2024

Ce document ainsi que sa référence bibliographique sont téléchargeables sur www.has-sante.fr



Haute Autorité de santé – Service communication et information
5 avenue du Stade de France – 93218 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX. Tél. : +33 (0)1 55 93 70 00
© Haute Autorité de santé – Mai 2024

Sommaire

Préambule	4
Décision	7
Présentation	8
Champs d'applicabilité	9
Résultats	10
Chapitre 1 : Le patient	11
Chapitre 2 : Les équipes de soins	14
Chapitre 3 : L'établissement	19
Table des Annexes	23
Annexe 1. Liste des établissements géographiques rattachées à la démarche	24
Annexe 2. Synthèse des activités réalisées par l'établissement en 2024	25
Annexe 3. Programme de visite	29

Préambule

La certification, mission confiée à la Haute Autorité de Santé (HAS) par les ordonnances de 1996, est une procédure d'évaluation externe des établissements de santé publics et privés effectuée par des professionnels (des pairs) mandatés par la HAS : les experts-visiteurs. Cette procédure quadri-annuelle, indépendante de l'établissement et de ses organismes de tutelle, porte sur le niveau de qualité et de sécurité des soins délivrés aux patients. Obligatoire, elle est codifiée à l'article L6113-3 (et suivants) du code de la santé publique.

La certification constitue une des modalités de mesure de la qualité des soins en établissements de santé et vise l'appropriation des standards de la qualité par les établissements. Elle y favorise également la mise en œuvre d'une dynamique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Elle est une certification globale et non une certification de toutes les activités de l'établissement. En effet, le dispositif porte sur le fonctionnement global de l'établissement et n'a pas vocation à évaluer spécifiquement le fonctionnement de chaque secteur d'activité.

Elle fournit une évaluation de la qualité et de la sécurité des soins des établissements de santé aux usagers et aux Agences régionales de santé (ARS) sans se substituer aux inspections et contrôles de sécurité sanitaire menés par ces autorités de tutelle.

Cette démarche nationale est réalisée selon des standards internationaux : la procédure de certification est elle-même évaluée par l'International Society for Quality in Health Care via l'International Accreditation Program (IAP), le seul programme international qui accrédite les organismes qui accréditent des structures de soins. La HAS a obtenu de l'ISQua en 2018 le renouvellement de son accréditation pour son activité de certification.

Une évaluation qui s'appuie sur un référentiel élaboré par la HAS en concertation avec les professionnels de santé, les organisations représentatives et les représentants des usagers...

Chaque établissement de santé est évalué sur les critères génériques, s'appliquant à tout l'établissement, ainsi que sur des critères spécifiques relevant :

- de populations spécifiques : enfant et adolescent, patient âgé, personne en situation de handicap,
- de modes de prise en charge spécifiques : ambulatoire, hospitalisation à domicile (HAD), SAMU-SMUR, urgences, soins critiques (soins continus, soins intensifs et réanimation)
- de secteurs d'activités spécifiques : chirurgie et interventionnel, maternité, psychiatrie et santé mentale, soins médicaux et de réadaptation (SMR), unité de soins de longue durée (USLD).

Ce référentiel, publié sur le site Internet de la HAS, comprend des critères ayant des niveaux d'exigence différents :

- des critères standards correspondent aux attendus de la certification;
- des critères impératifs correspondent à ce que l'on ne veut plus voir au sein d'un établissement de santé. Ils ont un impact particulier dans la décision de certification. En effet, si une évaluation de l'un de ces critères est négative pour un ou plusieurs de ses éléments d'évaluation, la HAS se réserve le droit de ne pas accorder la certification de l'établissement.
- des critères avancés correspondent à des exigences souhaitées mais non exigibles à ce jour. Ils correspondent potentiellement aux critères de certification de demain et sont valorisés pour les établissements qui peuvent y répondre sous condition d'un niveau minimal sur l'ensemble des critères standards et impératifs.

| ... et sur des méthodes

- des patients traceurs pour évaluer la qualité et la sécurité de la prise en charge d'un patient dans l'établissement de santé
- des parcours traceurs pour évaluer la continuité et la coordination de la prise en charge des patients, le travail en équipe et la culture qualité et sécurité au cours d'un parcours de soins défini
- des traceurs ciblés pour évaluer la mise en œuvre d'un processus ciblé
- des audits systèmes pour évaluer les organisations de l'établissement et s'assurer de leur maîtrise sur le terrain
- des observations pour évaluer les conditions générales de qualité et de sécurité des soins.

| Un rapport de certification structuré en 3 chapitres

Les résultats des évaluations réalisées durant une visite de l'établissement par des experts-visiteurs se traduisent dans un rapport de visite articulé en cohérence avec les 3 chapitres du référentiel.:

- Le premier chapitre concerne directement le résultat pour le patient. Tout au long de sa prise en charge, ses droits sont respectés, ses besoins spécifiques pris en compte de la même façon que ses attentes et ses préférences. Au-delà, l'engagement du patient est recherché. Son implication comme partenaire de sa prise en charge, tout comme celle de ses proches et aidants, est favorisée par l'expression de son point de vue sur son expérience et le résultat des soins.
- Le deuxième chapitre concerne les équipes de soins, à tous les niveaux. La certification vise à apprécier leur capacité à rechercher la pertinence, l'efficacité et la sécurité des soins, à se concerter et se coordonner tout au long du parcours du patient. Elle met également l'accent sur la maîtrise des risques liés au soin. Les analyses des événements indésirables associés aux soins, notamment les événements indésirables graves ainsi que des rapports de certification précédents conduisent à mettre un accent particulier sur le risque infectieux et le risque lié aux médicaments.
- Le troisième chapitre concerne l'établissement et sa gouvernance (direction et commission/conférence médicale d'établissement). Cette dernière favorise l'insertion territoriale en lien avec les autres acteurs de l'offre de soins et médico-sociale. Elle impulse une dynamique forte d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins qui associe et soutient les équipes, ainsi que les patients, représentants d'usagers et associations de malades.

Cette structuration permet l'analyse croisée entre le résultat pour le patient, les pratiques mises en œuvre par les équipes de soins et la dynamique impulsée par la gouvernance de l'établissement et du groupement, le cas échéant.

| Une décision et un rapport rendus publics

Sur la base du rapport de visite, complété d'éventuelles fiches d'anomalies et des observations de l'établissement, la HAS adopte le rapport de certification et rend une décision. La HAS peut prononcer trois types de décision :

- une décision de certification valable quatre ans qu'elle peut assortir d'une mention ;
- une décision de non-certification impliquant la mise en œuvre d'une nouvelle procédure dans un délai maximum de deux ans ;
- une décision de certification sous conditions ; une nouvelle procédure est alors programmée dans un délai compris entre six et douze mois. À l'issue de cette seconde procédure, la HAS constate si l'établissement a rempli les conditions pour être certifié. Elle prononce alors une décision de certification, avec ou sans mention, ou une décision de non-certification.

Le rapport et la décision sont publiés sur le site Internet de la HAS et communiqués à l'autorité de tutelle de l'établissement.

L'établissement doit en assurer la plus large diffusion interne. Il doit notamment la porter à la connaissance des instances délibérantes, de la commission ou conférence médicale d'établissement et de la commission des usagers.

Ce rapport de visite est produit par l'équipe des experts-visiteurs dans un délai d'une quinzaine de jour après la fin des évaluations et de la réunion de restitution, il est transmis à l'établissement pour que celui-ci puisse formuler ses observations. Il sera remis également à la HAS et fera partie des éléments de référence pour l'élaboration du rapport de certification

Décision

Au vu des éléments mentionnés dans le présent rapport, issus de la visite sur site, la Haute Autorité de santé décide la certification de l'établissement.

Présentation

AP-HM - HÔPITAL DE LA TIMONE	
Adresse	264 rue saint pierre 13385 Marseille Cedex 5 FRANCE
Département / Région	Bouches-du-Rhône / Provence-Alpes-Côte d'Azur
Statut	Public
Type d'établissement	Centre Hospitalier Universitaire

Établissement(s) juridique(s) rattaché(s) à cette démarche (la liste des établissements géographiques se trouve en annexe 1)

Type de structure	N° FINESS	Nom de l'établissement	Adresse
Établissement juridique	130786049	ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE	80 rue brochier 13005 Marseille 05eme FRANCE

Synthèse des activités réalisées par l'établissement au 2024

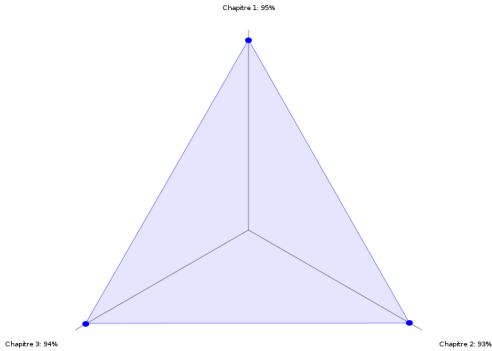
Vous trouverez en annexe 2 l'ensemble des activités réalisées par l'établissement.

Champs d'applicabilité

Champs d'applicabilité
Adulte
Ambulatoire
Chirurgie et interventionnel
Enfant et adolescent
Hospitalisation complète
Maladie chronique
Médecine
Pas de situation particulière
Patient âgé
Patient atteint d'un cancer
Patient en situation de handicap
Patient en situation de précarité
Programmé
SAMU-SMUR
Soins critiques
Tout l'établissement
Urgences

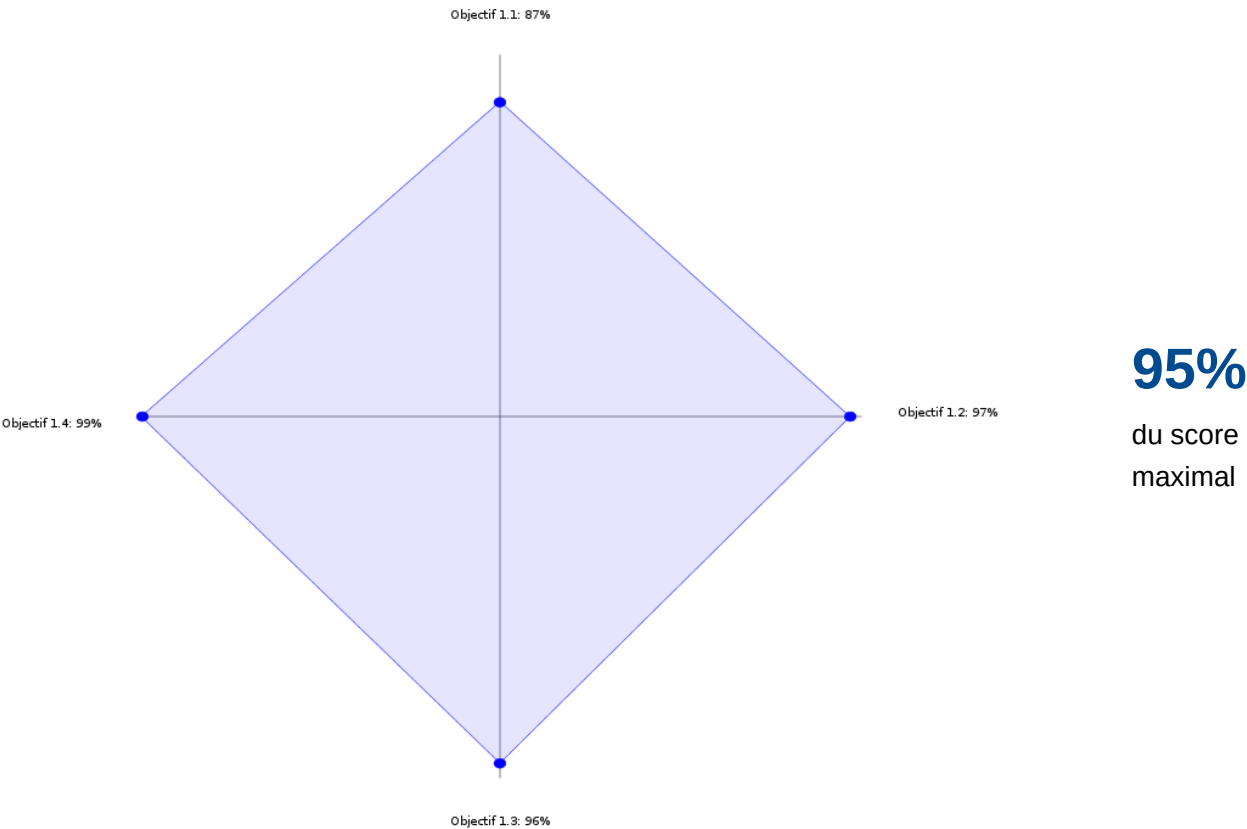
Au regard du profil de l'établissement,116 critères lui sont applicables

Résultats



Chapitre	
Chapitre 1	Le patient
Chapitre 2	Les équipes de soins
Chapitre 3	L'établissement

Chapitre 1 : Le patient



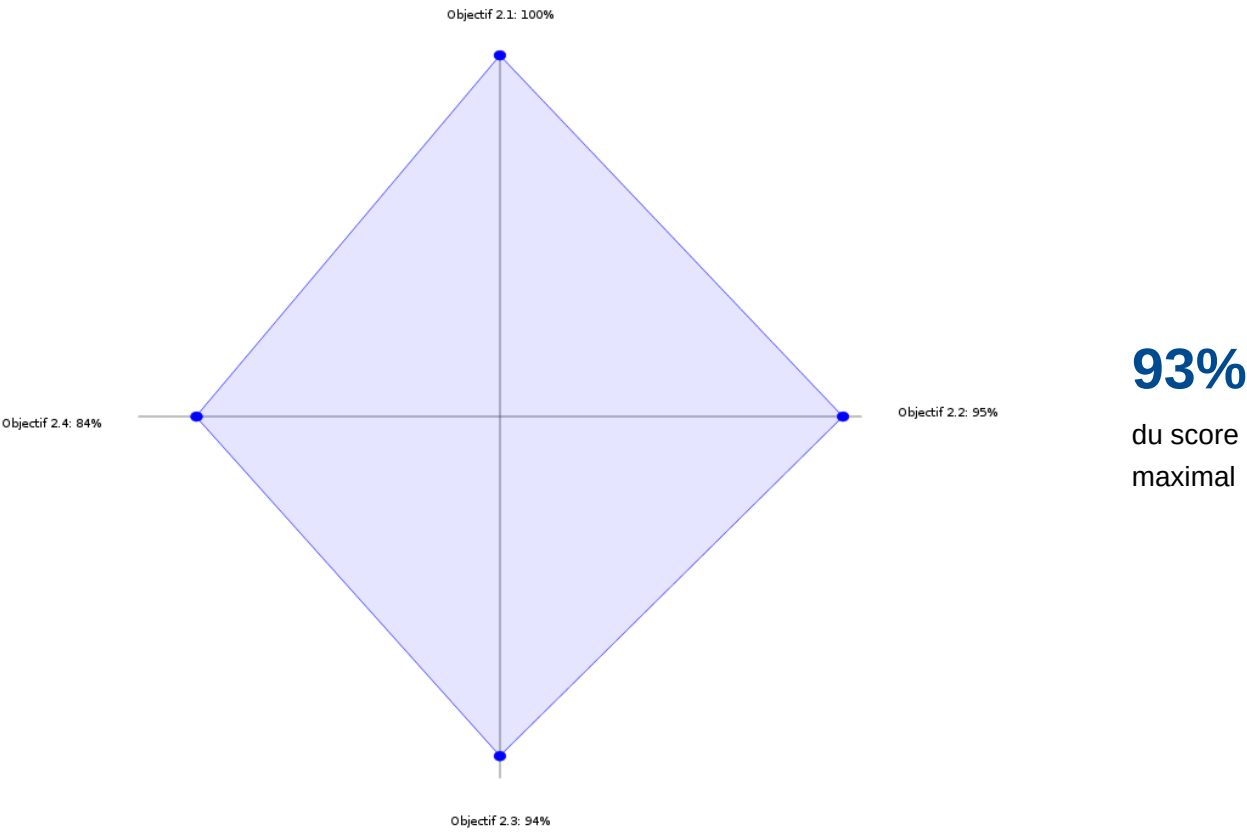
Objectifs		
1.1	Le patient est informé et son implication est recherchée.	87%
1.2	Le patient est respecté.	97%
1.3	Les proches et/ou aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec l'accord du patient	96%
1.4	Les conditions de vie et de lien social du patient sont prises en compte dans le cadre de sa prise en charge	99%

L'hôpital de la Timone est l'un des quatre sites de l'APHM avec l'hôpital Nord, Conception et l'hôpital Sud ; il comprend un service d'urgences adultes et enfants et des lits d'hospitalisation (ambulatoires et conventionnels) adultes et enfants pour des secteurs de médecine et de chirurgie. L'APHM a décliné sa politique de droits du patient et de prise en charge au niveau de la Timone. A l'exception de quelques patients arrivés en urgence, tous les patients rencontrés dans tous les secteurs investigués ont reçu une information claire et adaptée à leur degré de discernement sur leur état de santé, les hypothèses et confirmations diagnostiques, ainsi que les soins prodigués. Cette information est par ailleurs réalisée en cas de besoin de façon anticipée (exemple : information du patient en consultation anesthésique préalable sur les conditions de réveil en réanimation). Les affichages des chartes sont présents et adaptées aux services concernés. Le patient exprime son

consentement libre et éclairé sur son projet de soins et ses modalités : analyse bénéfique/risque expliquée de façon adaptée, de même que les modalités de prise en charge proposée (HAD, HDJ, etc). Dans tous les secteurs accueillants des mineurs, l'enfant ou l'adolescent est invité à exprimer son avis sur le projet de soins et ses modalités. Il a pu être remarqué l'information délivrée aux adolescents sur leur maladie et la prise en charge. Le patient bénéficie de messages renforçant sa capacité à agir pour sa santé, comme en médecine cardiologique, en oncologie ou en pédiatrie générale où il est constaté de nombreux supports d'information sur la prévention primaire. De même en radiologie une borne interactive permet de télécharger des messages de santé publique. Le patient bénéficie d'actions pour devenir acteur de sa prise en charge (exemple : actions d'information des infirmières de pratiques avancées et des IDE coordonnatrices dans tous les secteurs). Le patient peut désigner la personne à prévenir et la personne de confiance de son choix ; dans la plupart des cas il est retrouvé la trace dans le dossier de la désignation et de l'acceptation de la personne de confiance. Le patient, en prévision de sa sortie, est informé des consignes de suivi pour sa prise en charge. Il est informé des dispositifs médicaux qui lui sont implantés durant son séjour et reçoit les consignes de suivi appropriées ; l'identification et l'information du patient sont majoritairement tracées dans la lettre de liaison. Le patient est informé des produits sanguins labiles qui lui sont administrés. En ambulatoire, le patient reçoit les informations spécifiques aux modalités de sa prise en charge ; pour autant, en dehors de certains secteurs chirurgicaux, il n'est pas toujours retrouvé de document type « passeport » mais plutôt dans certaines spécialités une notice explicative sur la maladie (exemple en HDJ DTO). Les directives anticipées sont bien abordées dans les plaquettes d'information et un formulaire présent dans le dossier « type » du patient, mais les patients rencontrés sont peu informés sur leur droit à en rédiger et les équipes de soins informent peu le patient sur ce droit. Le patient a la possibilité, en situation de fin de vie, de faire valoir au plus tôt sa décision d'accéder aux soins palliatifs, quel que soit le service accueillant le patient. En dépit des affichages et communication sous différentes formes des représentants des usagers (adresse mail par exemple), les patients rencontrés connaissent peu les représentants des usagers et associations de bénévoles qui peuvent les accompagner. Le patient est invité à exprimer sa satisfaction principalement par e-satis, rarement par des questionnaires spécifiques : des modalités diverses existent pour faire part de son expérience ; pour autant, il est peu informé des modalités pour soumettre une réclamation ou déclarer un événement indésirable associé aux soins. Le patient reçoit une information claire et adaptée à son degré de discernement sur les modalités de prise en charge ; le livret d'accueil papier est disponible aux bureaux des entrées du site et en service de soins. Les affiches avec un QRcode renvoient vers le livret dématérialisé et sont présentes dans les services et dans les chambres des patients ; pour autant certains patients rencontrés n'ont pas eu un livret d'accueil. Les patients ne se sont pas tous encore emparés de cette modalité QR code. Par ailleurs ils ne sont pas toujours informés de leur droit à demander que le DMP et mon espace santé ne soient pas alimentés et ils ne savent pas toujours qu'il ne doit pas y avoir d'échanges avec les équipes par une messagerie non sécurisée. Dans de rares secteurs (pédiatrie, réanimation et chirurgie cardiaque par exemple), un livret d'accueil spécifique est remis aux parents ou aux patients. Le patient bénéficie dans tous les secteurs de la garantie du respect de ses droits. Il bénéficie d'abord du respect de son intimité et de sa dignité ; il a été constaté dans tous les secteurs d'activité des pratiques respectueuses (mise en place de paravents par exemple, utilisation de pyjama tissé non transparent pour les patients arrivant debout aux blocs opératoire), toujours exprimées par les patients, parfois en dépit de locaux exigus et inadaptés en termes de confort (exemple : pas de douches dans les chambres dans certains services tels que l'oncologie médicale ou les chirurgies adultes, chambres exigües ne permettant que difficilement la présence de proches la nuit). Un projet architectural se déploie jusque 2030 avec des ouvertures de nouveaux bâtiments entre 2025 et 2030 pour les services concernés. Le patient mineur bénéficie d'un environnement adapté (locaux, matériels, formation des professionnels à une communication adaptée, accueil et présence facilitée des parents). A titre d'exemple, un play room a été installé à l'entrée du bloc opératoire avec jeux et casque de réalité virtuelle permettant un accueil personnalisé de l'enfant et des parents avec l'objectif de réduire l'anxiété périopératoire. Un autre exemple se situe en radiologie interventionnelle où les SSPI adultes et enfants sont séparés. Le patient vivant avec un handicap bénéficie du maintien de son

autonomie tout au long de son séjour. De même le patient âgé bénéficie du maintien de son autonomie ; cependant l'aptitude du patient de plus de 75 ans ne fait pas systématiquement l'objet d'une évaluation. Le patient bénéficie du respect de la confidentialité des informations le concernant (exemple : pour les chambres à deux lits, proposition faite au patient de réaliser les entretiens dans une autre pièce en neurologie). Le recours à la contention mécanique fait toujours l'objet d'une décision médicale tracée et réévaluée, avec analyse du bénéfice/risque ; il est constaté une politique médicale de limiter au maximum le recours à cette contention (exemple : urgences adultes et pédiatriques, orthopédie, neuro chirurgie) avec une recherche de solutions alternatives (environnement adapté, inclusion de la famille, soutien psychologique en oncologie). Le patient reçoit une aide pour ses besoins élémentaires, même en situation de tension d'activité. Le patient bénéficie de soins visant à anticiper ou à soulager rapidement sa douleur (exemples : médecin anesthésiste dédié à la prise en charge pré et post opératoire au bloc opératoire pour la chirurgie traumatologique adultes et un IADE dédié en post-opératoire dans les secteurs de chirurgie). De nombreux protocoles sont mis en œuvre, les échelles douleur sont partout adaptées à la typologie des patients. Les proches et/ou aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec l'accord du patient. Ils peuvent s'impliquer dans la mise en œuvre du projet de soins (exemple : présence des proches possible pendant la séance en HDJ DTO, information et concertation avec les proches tout au long du processus de décisions complexes de limitation thérapeutique, éducation à la parentalité en pédiatrie générale, plaquette d'information COCON sur le parcours en soins précoces et coordonnés du nouveau- né vulnérable). Leur présence est grandement facilitée en dehors des heures de visite lorsque la situation le nécessite (lits accompagnants, réponse personnalisée aux demandes des proches, présence H24 des parents en réanimation pédiatrique, maison d'accueil proche du site pour les familles). Les conditions de vie et de lien social du patient sont prises en compte dans le cadre de sa prise en charge. Le patient en situation de précarité bénéficie du service social de l'établissement (exemple : une assistante sociale dédiée au secteur oncologie-hématologie pédiatrique, ou en traumatologie adultes, unité post-urgences gériatrique avec un lien constant entre l'assistante sociale et le conseiller assurance maladie pour le PRADO) et d'un accompagnement pour une orientation vers les services sociaux et associations adéquates. Le patient vivant avec un handicap ou ses proches et aidants exprime ses besoins et préférences pour une prise en compte dans son projet de soins. Le patient mineur atteint d'une maladie chronique ou vivant avec un handicap bénéficie de modalités de prise en charge intégrant les préoccupations de socialisation, éducatives et scolaires adaptées à la situation (école à l'hôpital pour les mineurs dialysés, en réanimation et en unité de surveillance continue pédiatrique ou encore salle de classe en pédiatrie générale). Les conditions de vie habituelles sont prises en compte notamment pour la préparation de la sortie (exemple : en UHCD, en neurochirurgie adultes, en orthopédie et traumatologie, en unité ambulatoire de chirurgie, liens avec les CMP le cas échéant ou la PMI, liens avec les prestataires à domicile pour la poursuite de la nutrition parentérale en gastro-entérologie).

Chapitre 2 : Les équipes de soins



Objectifs		
2.1	La pertinence des parcours, des actes et des prescriptions est argumentée au sein de l'équipe	100%
2.2	Les équipes sont coordonnées pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire tout au long de sa prise en charge	95%
2.3	Les équipes maîtrisent les risques liés à leurs pratiques	94%
2.4	Les équipes évaluent leurs pratiques notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patientèle	84%

Un travail de pertinence des parcours a été réalisé à la fois au niveau de l'APHM, de la Timone, mais aussi au niveau du GHT13 (quinze filières médicales définies et déployées avec les autres établissements, des actions de proximité avec des animations par l'APHM de maisons médicales de santé). La pertinence des actes et des prescriptions est également argumentée au sein des équipes. La pertinence des décisions de prise en compte s'appuie sur de nombreux protocoles actualisés adossés aux recommandations de bonnes pratiques ; des RCP sont mises en place dans plusieurs secteurs d'activité soit au niveau de l'établissement (exemple : unité médical ambulatoire, en neurologie maladies inflammatoires), soit avec d'autres structures publiques et privées (RCP UNV par exemple) ; un score de prédiction de détérioration est utilisé en post-urgence gériatrique à partir de données dynamap. La pertinence de l'orientation du patient par le SAMU est argumentée avec l'équipe

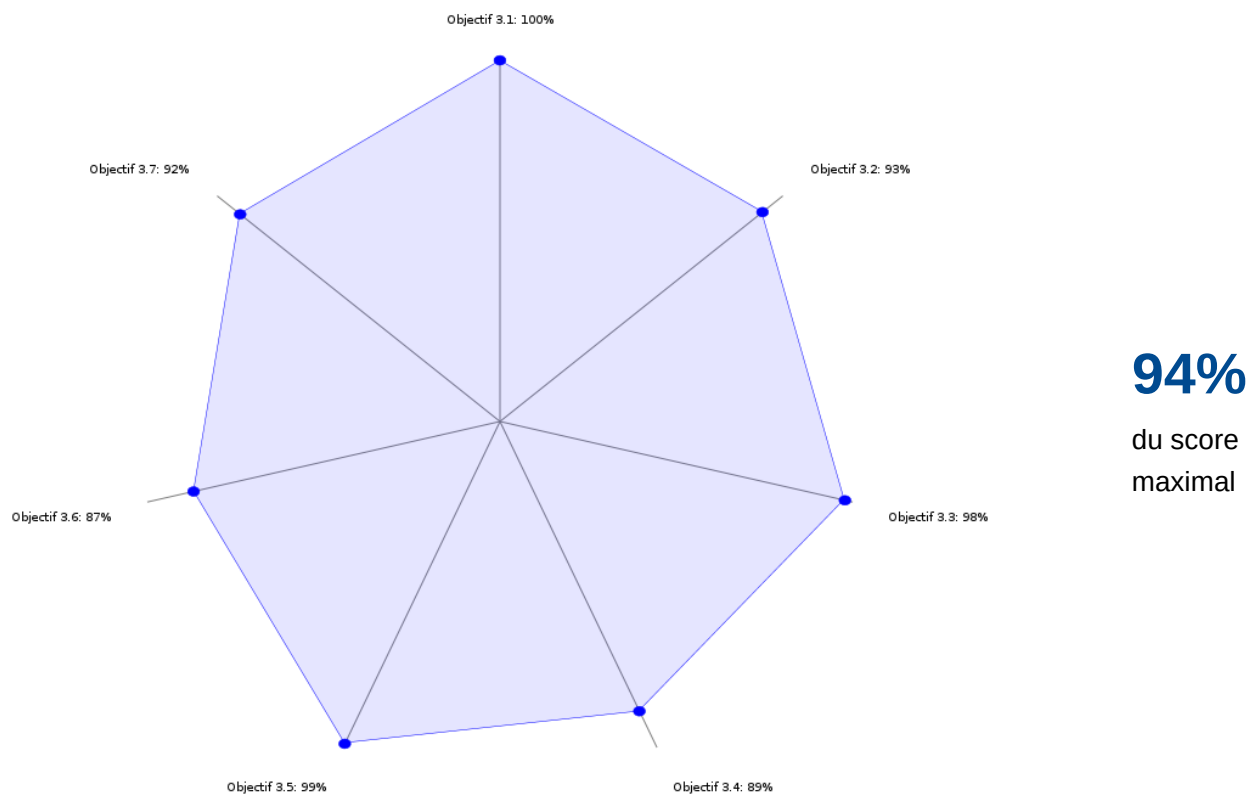
d'aval ; de nombreuses filières d'admission directe dans les services spécialisés sont utilisées par le SAMU et les SMUR (exemple : filière coordonnée neuro vasculaire avec appel du stroke center et une conférence à trois SAMU-équipe stroke center et neuroradiologue, ou l'organisation ambulatoire pour les urgences du membre supérieur sans passer par le service des urgences, ou encore le parcours bypass pour les anesthésies locorégionales sans passage en SSPI et entrée directe en chirurgie ambulatoire). La prescription d'une HAD est envisagée dans le cadre du projet de soins dès l'admission du patient en court séjour (exemple : prise en charge coordonnée avec l'HAD de la Conception ou réseau soins palliatifs Bouches-du-Rhône). La pertinence des prescriptions d'antibiotiques est argumentée et réévaluée. Les recommandations de bonnes pratiques actualisées sont facilement accessibles à partir du dossier informatisé du patient ; des livrets adultes et enfants ont été remis à jour avec l'aide du référent antibiothérapie ; la traçabilité de la réévaluation à 7 jours est effective. La pertinence de la transfusion de produits sanguins labiles est argumentée (dossier transfusionnel entièrement dématérialisé incluant prescription, surveillance, facteurs de risque, incidents, étapes non réalisées). Les équipes se coordonnent de façon pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle tout au long de la prise en charge du patient. Chaque appelant au SAMU pour un problème de santé bénéficie d'une régulation médicale. Le dossier médical préhospitalier informatisé des SMUR comporte tous les éléments nécessaires à la poursuite de la prise en charge du patient. Les équipes des urgences assurent au patient une orientation dans les circuits adaptés à sa prise en charge : tri réalisé par des IOA formés, délais d'attente affichés, évaluation de la gravité des patients affichée sur les PC des soignants pour faciliter les conduites à tenir concernant l'accueil de patients chroniques et vulnérables. Les équipes de soins ont accès aux informations du patient avec un système d'information adapté ; dans la très grande majorité, les professionnels tracent en temps utile leurs interventions. Les équipes se coordonnent pour la mise en œuvre du projet de soins avec une évaluation des besoins et préférences du patient (nombreux staffs dans tous les secteurs pluriprofessionnelles et pluridisciplinaires avec présence des professionnels en soins de support, nombreuses IDE coordonnatrices). La sécurité de la prise en charge médicamenteuse du patient bénéficie d'un début de conciliation des traitements médicamenteux : conciliation médicamenteuse d'entrée pour les patients en neurologie et pathologie du mouvement pour les patients âgés, entretiens pharmaceutiques chez les patients adultes et pédiatriques traités par thérapie orales anticancéreux ou les patients adultes et enfants suivis pour greffes d'organes solides. Les équipes se coordonnent dans le cas où le patient n'a pas été orienté dans l'unité adaptée faute de disponibilité. Des formations sont mises en place pour les professionnels des secteurs adultes qui peuvent accueillir des mineurs. L'équipe de soins peut faire appel si besoin à un réseau d'équipes de recours ou d'expertise. De nombreuses équipes de recours sont actives : gériatrie, psychiatrie, douleur, infections, soins palliatifs, hygiène. Des équipes d'expertise sont sur place : maladies rares, infections ostéo articulaires sur prothèses à l'IHU, etc. Les acteurs de la programmation opératoire sur les différents blocs se coordonnent et tiennent compte de la priorisation des urgences (réunions hebdomadaires de programmations opératoires ajustable en cas de besoins). Pour autant, les écarts de programmation ne sont pas toujours analysés conjointement entre équipe de chirurgie, d'anesthésie et secteurs interventionnels. Les secteurs interventionnels et les secteurs de soins échangent toutes les informations utiles relatives au patient (exemple : fiches de liaison unités/plateaux techniques avec des items pour le brancardier). Aux blocs adultes et enfants et dans les secteurs interventionnels, la check List « sécurité du patient » est utilisée de manière efficace. Tous les secteurs interventionnels bénéficient d'une check List adaptée et mise en œuvre de façon systématique : néanmoins la check List n'est pas toujours réalisée en présence des personnes concernées (étape 3) ; un audit réalisé en novembre 2023 a montré les marges d'amélioration et posé des actions à mettre œuvre (plan en cours). En phase de transition adolescent-adulte, les équipes se coordonnent pour assurer la continuité de la prise en charge du patient ; par exemple, dans un lieu dédié (l'APPART) sont organisées les consultations entre pédiatres référent et spécialistes adultes -notamment pour les maladies chroniques- ou encore la coordination entre pédopsychiatrie du site de la Conception et équipe « adultes » de la Timone. Le carnet de santé, le dossier du patient et le dossier médical mon espace santé (DMP) sont majoritairement mis à jour de manière synchronisée pour assurer la continuité des soins. Une démarche palliative pluridisciplinaire,

pluriprofessionnelle, coordonnée et protocolisée est mise en œuvre pour les patients en fin de vie, avec une mobilisation d'une équipe mobile intervenant sur trois sites de l'APHM dont la Timone et mobilisable H24 et des démarches avec décision de LATA prises en concertation en RCP avec cette équipe mobile. Une lettre de liaison à la sortie est très majoritairement remise au patient et permet la continuité du parcours de soins. Les équipes respectent les bonnes pratiques d'identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge (lieux adéquats, professionnels formés, bracelet d'identification, cellule d'identitovigilance APHM et la Timone). Les équipes maîtrisent la mise en application des vigilances sanitaires. La politique de sécurisation de la prise en charge médicamenteuse APHM est portée par le COSEPS (comité de sécurisation des produits de santé) ; ce comité se décline en plusieurs groupes de travail pluridisciplinaires. La PUI est gérée à l'échelle de l'APHM avec deux services transversaux (service central de la qualité et de l'information pharmaceutique et le service central des opérations pharmaceutiques) et les activités pharmaceutiques réalisées sur chaque site dont La Timone. De façon très générale sur la Timone, le circuit du médicament est sécurisé et adapté aux besoins des services (exemples : dotation hebdomadaire avec une IDE coordonnatrice s'assurant des commandes, un praticien référent dans le service, traitements personnels stockés dans un local sécurisé). Les équipes respectent les bonnes pratiques de prescription et de dispensation des médicaments (exemples ; formation des prescripteurs, guides de prescription, délivrance bi hebdomadaire des anti-infectieux nécessitant une prescription restreinte et nominative, transport des médicaments sécurisé avec lecteur QR code au départ de la pharmacie et à l'arrivée). L'analyse pharmaceutique de niveau 3 est réalisée pour tout entrant ; cependant cette analyse n'intègre pas les éléments du dossier pharmaceutique du patient (ordre des pharmaciens/assurance maladie). La dispensation sur la Timone est soit globale avec deux dispensations hebdomadaires, soit nominative pour certaines molécules à risques et onéreuses ; dans les réanimations et unités de soins continus, des armoires sécurisées informatisées sont en place. Les équipes respectent les bonnes pratiques d'administration des médicaments (utilisation d'étiquettes institutionnelles pour les injectables, préparation des médicaments au plus près de l'administration, traçabilité de l'administration). Les équipes maîtrisent l'utilisation des médicaments à risque. Une politique a été définie au niveau de l'APHM et appliquée à la Timone (liste institutionnelle et liste spécifique à chaque service, programme de formations des professionnels). Les règles de stockage et de transport de ces médicaments à risque sont très majoritairement respectées. Cependant dans un nombre très restreint d'hôpitaux de jour, il a été constaté une absence de contrôle de température le week-end des réfrigérateurs contenant des médicaments à risque thermosensibles. Au moment de la visite, l'établissement a presque achevé la mise en place de nouveaux réfrigérateurs permettant ce suivi avec un enregistrement de température intégré, sauf dans ces quelques hôpitaux de jour. L'établissement a très vite réagi en visite, a rédigé une procédure de suivi des températures des réfrigérateurs pour le moment sans système d'enregistrement de température avec une organisation adéquate. La liste des médicaments à risque est connue des professionnels rencontrés et une démarche spécifique pour la préparation de ces médicaments a été protocolisée (check-list et apposition d'un affichage pour éviter l'interruption de tâches pendant la préparation). L'approvisionnement, le stockage et l'accès aux produits de santé sont réalisés la plupart du temps conformément aux recommandations de bonnes pratiques. Cependant si tous les transports de médicaments et notamment ceux à risque font l'objet de transports sécurisés sur le site (coursiers formés, contenants sécurisés, vérification au départ de la pharmacie et à l'arrivée), il a été constaté une fois un transport dans un contenant non sécurisé. Un rappel a été fait au professionnel concerné. Les équipes maîtrisent le risque de discontinuité de la prise en charge médicamenteuse du patient vulnérable à sa sortie ; néanmoins le bilan thérapeutique n'est pas toujours retrouvé dans la lettre de liaison ou le compte-rendu d'hospitalisation. Les équipes maîtrisent la sécurité transfusionnelle (dématérialisation de tout le dossier transfusionnel (en pré, per et post transfusion) avec un programme de formation, pour chaque étape de la transfusion, basé sur les protocoles à jour, des modalités de transport définies par service en fonction de ses besoins, une mesure du taux de destruction. Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les bonnes pratiques d'hygiène des mains (connaissance et suivi de l'ICSHA dans la plupart des services). Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les précautions standard et complémentaires : CLIN de

site actif, formation des professionnels, gestion des excréta, surveillance des ISO, etc. Des audits ont lieu régulièrement sur certaines thématiques (exemples : hygiène des mains, zéro bijou, dispositifs invasifs, etc). Les équipes maîtrisent les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie liés aux actes invasifs protocoles adaptés à chaque secteur de chirurgie et interventionnel, avec livret de bonnes pratiques dans chaque salle de bloc. Les équipes maîtrisent le risque infectieux lié au circuit des dispositifs médicaux invasifs : un comité de pilotage APHM a été maintenu. A l'Hôpital de la Timone, les circuits de désinfection des endoscopes pour les adultes et les enfants sont sécurisés (check-list adaptée et utilisée, carnets de bords des endoscopes, formation des professionnels, armoires de stockage chez les adultes, dispositif TYPOON pour la pédiatrie). Les équipes maîtrisent le risque infectieux liés aux dispositifs invasifs en appliquant les précautions adéquates. Les équipes des secteurs interventionnels maîtrisent le risque infectieux en respectant les bonnes pratiques per-opératoires : par exemple les patients porteurs de germes sont identifiés dans le dossier patient informatisé et signalés pour le programme opératoire. La collaboration entre blocs et équipe du CLIN repose sur une organisation de référents côté bloc et côté CLIN. Il a été remarqué quelques tenues de bloc non conformes aux bonnes pratiques (masque en collier) et un suivi des ISO non réalisé en continu dans certains secteurs. Les équipes pluriprofessionnelles maîtrisent le risque de dépendance iatrogène. Les équipes respectent les recommandations et obligations vaccinales pour les professionnels de santé. Les équipes maîtrisent les risques liés à l'utilisation des rayonnements ionisants ; cependant le patient n'est pas toujours informé des doses reçues. L'autorisation de sortie du patient en chirurgie ambulatoire est validée sur la base d'un score. L'organisation des transports des patients en intrahospitalier vient d'être complètement révisée au niveau de l'APHM ; elle consiste à harmoniser la gestion des ressources humaines et des bonnes pratiques, restructurer les périmètres et informatiser la gestion des demandes. Elle est entrée en application dans un seul périmètre géographique sur cinq prévus ; au moment de la visite, cette organisation n'a donc pas encore porté tous ses fruits en matière de délais de transport en lien avec l'activité et les besoins des services. En ce qui concerne l'évaluation des pratiques professionnelles, la situation est hétérogène dans les différents secteurs d'activité de la Timone. Certaines équipes améliorent leurs pratiques en se fondant sur l'analyse de leurs résultats cliniques et sont en capacité de mettre en place un plan d'actions (exemple : EPP douleur aux urgences pédiatriques, EPP élaboration de scores pour mise en place de l'antibiothérapie aux urgences adultes et réanimation médicale, EPP intérêt de la radiologie systématique du thorax dans la prise en charge des bronchiolites). De même certaines équipes améliorent leurs pratiques en se fondant sur la satisfaction du patient, plus rarement sur l'expérience patient à l'exception de quelques services (HDJ onco-hématologie pédiatrie, coronarographie). La plupart des équipes améliorent leurs pratiques en se fondant sur leurs résultats d'indicateurs notamment les indicateurs qualité et sécurité des soins (exemple : filière neuro vasculaire, blocs opératoires). Un tableau de bord sécurité des soins est élaboré par service avec un score donnant accès à un label. La plupart des équipes améliorent leurs pratiques en analysant les événements indésirables associés aux soins qu'elles ont déclarés (nombreux et réguliers RMM et CREX dans les secteurs interventionnels et de soins critiques notamment). Cependant toutes les équipes éligibles ne connaissent pas toujours le dispositif d'accréditation malgré l'existence de plusieurs équipes accréditées. Les équipes des secteurs de soins critiques améliorent leurs pratiques en se fondant notamment sur les modalités de prise en charge de leurs patients ; pour autant toutes les équipes concernées ne tiennent pas un registre de refus d'admission et les réhospitalisations à 48/72 heures ne sont pas suivies dans tous ces secteurs. La plupart des équipes des secteurs interventionnels améliorent leurs pratiques en analysant les modalités de réalisation de la check List (analyse des GO/No GO, suivi réalisé ou initié dans certains secteurs d'indicateurs de pratiques et d'utilisation). Des actions d'amélioration de la qualité des résultats de biologie médicale et d'anatomopathologie sont mises en place (exemple : protocole commun laboratoire/soins pour le bilan thrombolyse en urgence). Des actions d'amélioration des résultats d'examens d'imagerie médicales sont mises en place (RCP en cas d'atteinte osseuse par exemple, consultation d'imagerie pour les patients douloureux en oncologie avant radiologie interventionnel). Les activités de prélèvement et de greffes d'organes et de tissus sont évaluées et se traduisent par des plans d'actions d'amélioration dont les effets sont mesurés (équipe joignable 24H/24,

collaboration avec le réseau de transport de Marseille, information personnalisée à l'intention de la population marseillaise sur le don d'organes).

Chapitre 3 : L'établissement



Objectifs		
3.1	L'établissement définit ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire	100%
3.2	L'établissement favorise l'engagement des patients individuellement et collectivement	93%
3.3	La gouvernance fait preuve de leadership	98%
3.4	L'établissement favorise le travail en équipe et le développement des compétences	89%
3.5	Les professionnels sont impliqués dans une démarche de qualité de vie au travail impulsée par la gouvernance	99%
3.6	L'établissement dispose d'une réponse adaptée et opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté	87%
3.7	L'établissement développe une dynamique d'amélioration continue de la qualité des soins	92%

L'APHM est l'établissement pivot du système de santé régional. IL se compose de quatre sites (hôpital de la Timone, hôpital Nord, hôpital Conception et hôpital Sud), 25 pôles d'activités médicales et 250 services (au total 3300 lits et places), 93 centres labellisés Maladies rares, un centre d'enseignement et de recherche avec l'Institut Méditerranée Universitaire (infectiologie) et trois centres de recherche hospitalo-universitaires, 13

instituts de formation, 3 centres de santé (Aygaldes, Flamants et Aubagne), une maison des femmes à Marseille. L'APHM est établissement support du GHT 13 et a été en 2023 à l'initiative d'un projet stratégique de territoire, avec la mise en oeuvre des postes partagés en médecine et en chirurgie pour favoriser le développement de filières et conforter son attractivité, le développement d'une filière gériatrique avec les établissements médico-sociaux. L'établissement a également tissé des liens avec les cliniques et la médecine de ville. Il est le premier employeur de la région PACA avec 3000 professionnels médicaux et 13000 professionnels non médicaux. La stratégie en politique de santé, en politique des ressources humaines et en maîtrise des risques est élaborée au niveau central et déclinée sur chaque site. En ce qui concerne la Timone, le site contient 1047 lits adultes et 274 pour les enfants soit 40% de l'APHM, avec une activité importante d'urgences adultes (89000 passages) et enfants (43000 passages), une activité médicale et chirurgicale adultes et enfants importante (62500 entrées en hospitalisation, 20500 interventions chirurgicales). L'APHM donne à ce site des ambitions à 10 ans se traduisant par un projet architectural permettant d'y répondre, notamment une capacité accrue de réception des urgences, une plateforme d'oncologie mutualisée, une unité neuro-vasculaire redimensionnée de 16 à 24 lits, une activité de chirurgie ambulatoire et la mise en place du JO en chirurgie pour les disciplines médicales interventionnelles, le maintien des activités chirurgicales lourdes, la réunion de la maternité niveau 3 actuellement distante et l'hôpital d'enfants, l'augmentation de la capacité de réanimation pédiatrique de recours, le développement de l'ambulatoire pédiatrique. Le patrimoine architectural est aujourd'hui hétérogène avec les bâtiments très récents et d'autres ne correspondant plus totalement aux besoins des patients et des professionnels. Une vaste opération de modernisation immobilière a débuté par l'ouverture du biogénopôle en 2023, va se poursuivre par la mise en service du nouveau bâtiment du SAMU zonal et du Centre antipoison en 2025 (travaux débutés), puis du nouveau bâtiment Femme, Parents, Enfants en 2028, la plateforme ambulatoire d'oncologie en 2028 et la fin de la rénovation et de restructuration du plus grand bâtiment en 2030 (travaux débutés), dans un contexte budgétaire et financier très contraint et tendu. L'APHM a défini ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire. Elle participe aux projets territoriaux de parcours dans le cadre du GHT avec de très nombreuses filières organisées, politique « d'aller vers » les établissements médico-sociaux et la médecine de ville (commission ville-hôpital, collaboration entre pédiatrie et équipe de liaison de pédopsychiatrie). Elle a des relations avec les cliniques avec une stratégie de débord pour les moments de tension dans les secteurs de soins critiques notamment. Elle participe à la coordination des parcours sur le territoire et hors territoire dans le cas d'activités de recours. L'Hôpital de la Timone est un établissement de recours pour d'autres CHU pour certaines maladies rares par exemple. Pour les admissions en urgence dans les unités spécialisées, l'APHM a mis en place des modalités de prise en charge rapide déclinée sur la Timone (exemples : SAS aux urgences, intervention de l'équipe mobile de gériatrie aux urgences, SOS mains, en cardiologie la mise en place d'une équipe mobile d'assistance circulatoire qui va chercher les patients sur le territoire pour les hospitaliser rapidement en chirurgie ou réanimation). Elle contribue à prévenir les passages évitables des personnes âgées aux urgences générales (SAS aux urgences, intervention de l'équipe mobile de gériatrie aux urgences, hotline personnes âgées avec une infirmière de pratique avancée). Les modalités de communication permettent aux usagers et aux médecins de ville de contacter aisément l'établissement (exemple : en pédiatrie de spécialités, numéros directs en neurologie et en pneumologie à disposition des correspondants de ville et autres hôpitaux, messagerie sécurisée sur tout le site) ; néanmoins les professionnels ne connaissent pas toujours les types de documents du dossier patient reversé au DMP. L'établissement promeut la recherche clinique en son sein et en lien avec d'autres acteurs du territoire (structuration territoriale depuis 2022, plus de 2000 articles publiés par an, plus de 1900 programmes de recherche en cours, recherche para médicale lauréate, association des établissements du GHT et du CLCC à certains programmes de recherche). L'APHM favorise l'engagement des patients individuellement et collectivement. Cette volonté institutionnelle se traduit à la Timone par la promotion de toutes les formes de recueil de l'expression du patient (exploitation d'e-satis notamment, développement des PREMS et des PROMS). Le site commence dans de nombreux secteurs à mobiliser les actions d'expertise des patients (patients pairs dans les programmes d'éducation thérapeutique par exemple, enquête sur 200 patients

sur la Timone pour la mise en place de repas végétariens, plateforme collaborative pour le projet architectural 2030, charte de l'inclusion de l'usager dans les projets APHM) ; l'impact des intégrations de l'expertise des patients n'est pas encore réalisé et les patients ne participent pas toujours aux démarches collectives de développement et d'amélioration des pratiques. La Timone a une communication centrée sur le patient. L'APHM a engagé une politique de bientraitance déclinée sur la Timone (exemples : charte de bientraitance, formations des professionnels, démarche pour mieux gérer l'agitation et les chutes de patients dans le secteur de cardiologie, soins de support en oncologie). La Timone participe au repérage et à la prise en charge des maltraitements éventuelles subies par les patients et lutte contre la maltraitance en son sein (circuits d'alerte connus des professionnels, outils de repérage, interventions du service social pour les patients vulnérables et des psychologues). La Timone assure l'accessibilité de ses locaux aux personnes vivant avec un handicap locomoteur mais certains bâtiments anciens non encore rénovés ou certains accès extérieurs aux bâtiments permettent difficilement l'accessibilité notamment aux personnes vivant avec un handicap sensoriel (exemples : bâtiments de dermatologie et d'oncologie). La Timone favorise l'accès aux soins des personnes vulnérables avec une intervention du service social rapide sur cette population. Le site s'est organisé pour permettre au patient d'accéder rapidement à son dossier ; cependant l'établissement n'informe pas le patient de son droit à demander de ne pas alimenter son DMP. La Timone favorise l'accès aux innovations pour les patients (nombreux centres de compétences et de référence, y compris pour les maladies rares). Le site implique les représentants des usagers et des associations de patients dans ses instances et dans la vie institutionnelle (une CDU à l'APHM et une commission locale des usagers sur chaque site dont la Timone, présence dans de nombreuses sous-commissions de la CME et des groupes de travail, projet des usagers de l'APHM élaboré en 2022). La gouvernance de l'APHM fait preuve de leadership ; cette capacité à conduire les collectifs professionnels se déclinent au niveau de la Timone. Le management institutionnel et de site fonde son management sur la qualité et la sécurité des soins : politique qualité/sécurité déclinée en plans d'actions institutionnels et de secteurs d'activité, implication forte des instances, binômes cadre de santé et chef de service co-animateurs des démarches qualité/sécurité, tableaux de bord par services ; une majorité des professionnels rencontrés savent citer des actions du plan qualité en lien avec leurs activités. La culture de sécurité des soins est soutenue (évaluation régulière de la culture sécurité au niveau des services avec un score annuel et un benchmarking par pôle et pour le site). L'adéquation ressources humaines/qualité-sécurité des prises en charge est pilotée ; de nombreux dispositifs concernant l'accueil, l'intégration et la formation des professionnels médicaux et non médicaux, les pools de remplacement ont permis de fidéliser et de recruter des professionnels après une période particulièrement difficile durant laquelle les postes vacants ont obligé le site de la Timone à fermer des lits et des services. Ces recrutements ont permis depuis le deuxième semestre 2023 de combler la quasi-totalité des postes vacants et de sécuriser l'ensemble des services et des lits réouverts. Les responsables médicaux et paramédicaux d'équipes bénéficient de formations ou de coaching en management. L'APHM et plus spécifiquement la Timone favorise le travail en équipe et le développement des compétences. La gouvernance impulse le travail en équipe sous différentes formes : temps dédié dans la plupart des services, réflexion et mise en œuvre d'une synchronisation des temps médicaux et non médicaux, refonte de l'organisation dans le secteur de pédiatrie et aux blocs opératoire, plus de 50 projets déposés par les services pour 2023-2024 relatifs à l'engagement collectif sur différents sujets tels que l'attractivité, le développement durable ou le management. La gouvernance impulse et soutient des démarches spécifiques d'amélioration du travail en équipe (trois équipes médicales accréditées, d'autres en cours). Les connaissances et les compétences individuelles et collectives des équipes sont assurées : évaluation individuelle des professionnels non médicaux et début d'une évaluation individuelle des professionnels médicaux, recherche de l'adéquation entre les missions et les compétences des professionnels ; néanmoins la plupart des équipes rencontrées n'ont pas eu de propositions de programme intégrés d'acquisition et de maintien de compétences. L'APHM promeut et soutient le recours au questionnement éthique par l'ensemble des acteurs ; un espace éthique est à la disposition des professionnels et des gouvernances des différents sites. A la Timone les professionnels sont régulièrement sensibilisés au questionnement éthique, peuvent en parler en réunion

d'équipe et staffs (exemple : en spécialités pédiatriques, réunion pluridisciplinaire pour les patients pouvant relever un arrêt de soins) ; ils font appel en cas de besoin aux ressources extérieures en particulier l'équipe mobile de soins palliatifs. L'APHM met en œuvre une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail, concerté avec les instances représentatives des professionnels et reposant sur un questionnaire de satisfaction des professionnels ; cette politique se traduit à la Timone par des espaces temps de discussion collectives, des recherches de solutions visant à améliorer l'organisation du travail dans les unités et des dispositifs d'écoute pour un soutien psychologique ; des actions visant l'accueil et l'intégration des professionnels sont soulignées par les professionnels comme étant des éléments de qualité de vie professionnelle, ainsi que les salles de repos, la salle de sport ou la salle « zen ». Plusieurs organisations sont en place (exemple : une commission QVT pour les professionnels médicaux). Les professionnels de nuit peuvent se référer à l'encadrement paramédical mais aussi à l'encadrement médical (exemple en chirurgie traumatologie et rachis). La gouvernance met en place des mesures de gestion des difficultés interpersonnelles et des conflits : une commission de gestion des difficultés interpersonnelles, médiations, mentorat. L'APHM dispose d'une réponse adaptée et opérationnelle aux risques auxquels elle peut être confrontée. La gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles est pilotée au niveau de l'APHM et déclinée sur le site de la Timone avec une direction médico-administrative de crise, des entraînements réguliers avec RETEX. La prévention des atteintes aux personnes et aux biens est maîtrisée (plan de sécurisation à jour, responsables locaux de sécurité, accès protégés, professionnels formés aux règles de sécurité et équipés de matériels de protection) ; pour autant certains secteurs hébergeant des patients à risque de fugue par exemple ne sont pas complètement sécurisés. Les risques environnementaux et enjeux du développement durable sont maîtrisés : axe fort du projet d'établissement en cours de finalisation sur l'écologie dans le soin et autour du soin, organisation institutionnelle sur ces thématiques, référent et comité de pilotage développement durable sur chaque site dont la Timone, nombreuses actions impliquant les professionnels, tableaux de bord par secteur d'indicateurs de développement durable ; le circuit des déchets est majoritairement conforme aux règles d'hygiène et de tri. La prise en charge des urgences vitales est maîtrisée dans l'enceinte de la Timone : numéro d'appel unique et connu des professionnels, chariots dédiés, accessibles et vérifiés, évaluation du dispositif ; les formations AFGSU ont repris après la période Covid ; il n'y a pour l'instant d'exercices de simulation que dans certains secteurs de soins critiques (exemple en réanimation cardiaque ou chirurgie de la main). L'APHM développe une dynamique d'amélioration continue de la qualité des soins qui se traduit à la Timone d'abord par une mobilisation des équipes dans la maîtrise des bonnes pratiques (implication des instances du site, travail en équipe sur les actions d'amélioration des prises en charge de patients) ; pour autant tous les secteurs n'ont pas réalisé d'évaluation de leur activité lors de revue de pertinence des admissions et des séjours. Le point de vue du patient est pris en compte dans le programme d'amélioration continue de la qualité ; cependant les professionnels rencontrés ne connaissent pas les avis et recommandations issues de la CDU de l'APHM ou du comité local des usagers. Les indicateurs qualité et sécurité des soins sont analysés, exploités et communiqués au niveau de l'APHM et de la Timone ; les professionnels se sont approprié ces indicateurs ou ceux spécifiques à leur service. De même, la survenue d'événements indésirables liés aux soins sont analysés au travers un outil informatique de l'APHM piloté par le comité des vigilances et des risques, exploités et communiqués à la Timone. Les EIG sont déclarés et font l'objet d'une analyse approfondie. L'organisation en aval des urgences adultes et pédiatriques est analysée et s'améliore pour assurer un parcours intrahospitalier de qualité en toute sécurité. L'accréditation des médecins est promue, plusieurs équipes étant déjà accréditées ainsi que de nombreux professionnels médicaux. La HAS confirme la qualité des soins et décerne la certification pour 4 ans. Une nouvelle visite sera programmée dans l'année qui précède cette échéance. Dans l'intervalle, la HAS encourage prioritairement l'établissement à : Pérenniser le bon usage et l'analyse de la check list au bloc ; Homogénéiser l'analyse des résultats cliniques au sein des différentes unités ; Développer la recherche de l'expérience patient.

Table des Annexes

- Annexe 1. Liste des établissements géographiques rattachées à la démarche
- Annexe 2. Synthèse des activités réalisées par l'établissement en 2024
- Annexe 3. Programme de visite

Annexe 1. Liste des établissements géographiques rattachées à la démarche

Type de structure	N° FINESS	Nom de l'établissement	Adresse
Établissement juridique	130786049	ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE	80 rue brochier 13005 Marseille 05eme FRANCE
Établissement principal	130783293	APHM-HOPITAL DE LA TIMONE/ADULTES	264 rue saint pierre 13385 Marseille Cedex 5 FRANCE
Établissement géographique	130804297	APHM-HOPITAL DE LA TIMONE ENFANTS	264 rue saint pierre 13005 Marseille FRANCE

Annexe 2. Synthèse des activités réalisées par l'établissement en 2024

Catégorie / Champs d'applicabilité / Donnée de profil	Valeur
Autorisations	
Urgences	
Existence d'un soignant d'accueil et d'orientation	Oui
Si oui, l'accueil et l'orientation sont réalisés par IAO (infirmière d'accueil et d'orientation) ou par MAO (médecin d'accueil et d'orientation)	Oui
Existence de Structure des urgences générales	Oui
Existence de Structure des urgences pédiatriques	Oui
Hospitalisation à domicile	
Présence d'une astreinte opérationnelle soignante H24 et 7/7 (IDE se déplaçant au domicile)	Non
Autorisation de Médecine en HAD	Non
Autorisation d' Obstétrique en HAD	Non
Autorisation de SMR en HAD	Non
Autorisation de Prise en charge du cancer en HAD	Non
Tout l'établissement	
Existence d'une permanence d'accès aux soins de santé (PASS) dans votre établissement	Oui
Existence d'une solution d'informatisation du circuit du médicament à la PUI	Oui
Existence d'Unité de préparation des médicaments de chimiothérapie anticancéreuse	Oui
SAMU-SMUR	
Existence de SMUR général	Oui
Existence de SMUR pédiatrique	Oui
Existence d'Antenne SMUR	Non
Existence d'un SAMU	Oui
Soins critiques	
Présence de service de Réanimation (y compris soins intensifs et surveillance continue)	Oui
Présence de Réanimation enfant (hors néonatalogie)	Oui

Présence d'Unité de soins intensifs en cardiologie (USIC)	Oui
Présence d'Unité de surveillance continue (SC) adulte	Oui
Présence d'Unité de surveillance continue (SC) enfant	Oui
Médecine	
Autorisation de Traitement de l'insuffisance rénale chronique (hors péritonéale) en centre	Non
Autorisation de Traitement de l'insuffisance rénale chronique (péritonéale)	Non
Patient atteint d'un cancer	
Autorisation de Traitement des affections cancéreuses par chimiothérapie	Oui
Autorisation de Traitement des affections cancéreuses par radiothérapie (dont curiethérapie)	Oui
Chirurgie et interventionnel	
Autorisation de Chirurgie cardiaque	Oui
Autorisation d'Activité interventionnelle en cardiologie	Oui
Autorisation de Neurochirurgie	Oui
Autorisation d'Activité interventionnelle en neurologie	Oui
Autorisation d'Activité de greffe	Oui
Activité Urgences	
Urgences	
Nombre total de passages aux urgences dans l'année pour des patients de plus de 80 ans	9,674
Nombre de passages aux urgences générales	86,237
Nombre de passages aux urgences pédiatriques	38,143
SAMU-SMUR	
Nombre de Dossiers de Régulation Médicale (DRM)	362,453
Activité Hospitalière MCO	
Soins de longue durée	
Nombre de patients PEC durant l'année écoulée par une équipe mobile de gériatrie	0
Médecine	
Nombre de lit en Hospitalisation complète en Médecine	727

Chirurgie et interventionnel	
Nombre de lit en Hospitalisation complète en Chirurgie	431
Maternité	
Nombre de lit en Hospitalisation complète en Gynécologie-Obstétrique	0
Ambulatoire	
Nombre de places en Hospitalisation partielle en Médecine	131
Nombre de places en Hospitalisation partielle en Chirurgie	37
Nombre de places en hospitalisation partielle en Gynécologie-Obstétrique	0
Tout l'établissement	
Nombre de séances en hospitalisation partielle en Médecine	43,457
Enfant et adolescent	
Nombre de lit en Hospitalisation complète en Pédiatrie	212
Nombre de places en Hospitalisation partielle en Pédiatrie	53
Patient âgé	
Nombre de lit en Hospitalisation complète en Gériatrie	0
Nombre de places en Hospitalisation partielle en Gériatrie	0
Urgences	
Nombre de lit en UHCD	19
Activité Hospitalière SMR	
Soins Médicaux et de Réadaptation	
Nombre de lit en Hospitalisation complète en SMR	0
Nombre de places en Hospitalisation partielle en SMR	0
Activité Hospitalière SLD	
Soins de longue durée	
Nombre de lit en Hospitalisation complète en SLD	0
Activité Accident Vasculaires Cérébraux (AVC)	
Chirurgie et interventionnel	
Nombre de lits de l'Unité Neuro-Vasculaire (UNV)	26
Activité Hospitalière PSY	

Psychiatrie et santé mentale	
Nombre de lit en Psychiatrie générale en hospitalisation à temps plein	0
Nombre de lit en Psychiatrie infanto-juvénile en hospitalisation à temps plein	0
Nombre de lit en Psychiatrie en milieu pénitentiaire en hospitalisation à temps plein	0
Nombre Total de lit en Psychiatrie en hospitalisation à temps plein	0
Nombre de lit en Psychiatrie générale en hospitalisation de jour	0
Nombre de lit en Psychiatrie infanto-juvénile en hospitalisation de jour	0
Nombre de lit en Psychiatrie en milieu pénitentiaire en hospitalisation de jour	0
Nombre Total de lit en Psychiatrie en hospitalisation de jour	0
Nombre de CATTP en Psychiatrie générale	0
Nombre de CATTP en Psychiatrie infanto-juvénile	0
Nombre de CATTP en Psychiatrie en milieu pénitentiaire	0
Nombre Total de CATTP en Psychiatrie	0
Nombre de CMP en Psychiatrie générale	0
Nombre de CMP en Psychiatrie infanto-juvénile	0
Nombre Total de CMP en Psychiatrie	0
Sites opératoires et salles d'intervention	
Chirurgie et interventionnel	
Nombre total de salles (d'intervention ou d'exploration) des sites (calculé)	42
Ambulatoire	
Nombre de salles dédiées à la chirurgie ambulatoire	0
Activité Hospitalière HAD	
Hospitalisation à domicile	
Nombre total de patients pouvant être pris en charge simultanément en HAD	0

Annexe 3. Programme de visite

Nb	Méthode	Sous-méthode	Champs d'applicabilité	Description traceur
1	Patient traceur		Chirurgie et interventionnel Hospitalisation complète Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
2	Patient traceur		Chirurgie et interventionnel Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
3	Patient traceur		Chirurgie et interventionnel Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
4	Patient traceur		Médecine Ambulatoire Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
5	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé	

			Tout l'établissement	
6	Traceur ciblé			PSC
7	Traceur ciblé			Prescription intégrant, a minima, un antibiotique injectable
8	Traceur ciblé			PSC
9	Parcours traceur		Soins critiques Hospitalisation complète Adulte Enfant et adolescent Patient âgé Patient en situation de handicap SAMU-SMUR Tout l'établissement	
10	Traceur ciblé			Prescription intégrant, a minima, un médicament à risque per os
11	Parcours traceur		Médecine Ambulatoire Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
12	Traceur ciblé			ANTIBIOPROPH
13	Traceur ciblé			EI
14	Traceur ciblé			SAMU / SMUR / Urgences générales
15	Traceur ciblé			PSL
	Patient traceur		Médecine Ambulatoire Adulte	

16			Patient atteint d'un cancer Programmé Tout l'établissement	
17	Audit système			
18	Audit système			
19	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Patient âgé Patient en situation de handicap Urgences Tout l'établissement	
20	Patient traceur		Chirurgie et interventionnel Ambulatoire Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
21	Patient traceur		Médecine Ambulatoire Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
22	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
	Patient traceur		Chirurgie et interventionnel Hospitalisation complète	

23			Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
24	Patient traceur		Médecine Ambulatoire Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
25	Patient traceur		Chirurgie et interventionnel Ambulatoire Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
26	Patient traceur		Chirurgie et interventionnel Ambulatoire Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
27	Patient traceur		Médecine Ambulatoire Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
28	Parcours traceur		Médecine Ambulatoire Hospitalisation complète Enfant et adolescent Patient en situation de handicap	

			Programmé Tout l'établissement	
29	Audit système			
30	Patient traceur		Soins critiques Hospitalisation complète Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
31	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Patient âgé Patient en situation de handicap Urgences Tout l'établissement	
32	Parcours traceur		Chirurgie et interventionnel Soins critiques Hospitalisation complète Adulte Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
33	Audit système			
34	Audit système			
35	Audit système			
36	Audit système			
37	Audit système			

38	Patient traceur		Chirurgie et interventionnel Hospitalisation complète Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
39	Patient traceur			
40	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Urgences Tout l'établissement	
41	Parcours traceur		Chirurgie et interventionnel Ambulatoire Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
42	Parcours traceur		Chirurgie et interventionnel Ambulatoire Adulte Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
43	Patient traceur		Médecine Ambulatoire Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	

44	Patient traceur		Médecine Ambulatoire Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
45	Patient traceur		Soins critiques Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
46	Parcours traceur		Chirurgie et interventionnel Soins critiques Hospitalisation complète Adulte Pas de situation particulière SAMU-SMUR Tout l'établissement	
47	Patient traceur		Médecine Ambulatoire Adulte Patient atteint d'un cancer Programmé Tout l'établissement	
48	Traceur ciblé			PER OP
49	Patient traceur		Chirurgie et interventionnel Ambulatoire Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	

50	Traceur ciblé			Priorisation de l'unité de soins où est réalisée la transfusion :, Réanimation, USC, Orthopédie / Le type de produit est laissé à l'appréciation de l'EV
51	Patient traceur		Chirurgie et interventionnel Hospitalisation complète Patient âgé Patient en situation de handicap Urgences Tout l'établissement	
52	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
53	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Patient âgé Patient atteint d'un cancer Programmé Tout l'établissement	
54	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
55	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Programmé	

			Tout l'établissement	
56	Traceur ciblé			ANTIBIO'PROPH
57	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Urgences Tout l'établissement	
58	Patient traceur		Soins critiques Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
59	Audit système			
60	Traceur ciblé			SAMU / SMUR pédiatriques / Urgences pédiatrique
61	Audit système			
62	Patient traceur		Médecine Ambulatoire Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
63	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	

64	Audit système			
65	Patient traceur		Chirurgie et interventionnel Hospitalisation complète Adulte Pas de situation particulière Programmé Tout l'établissement	
66	Parcours traceur		Médecine Hospitalisation complète Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Urgences Tout l'établissement	
67	Traceur ciblé			Prescription intégrant, a minima, un antibiotique injectable
68	Audit système			
69	Audit système			
70	Audit système			
71	Patient traceur		Médecine Ambulatoire Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
72	Parcours traceur		Médecine Hospitalisation complète Adulte Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé	

			Tout l'établissement	
73	Traceur ciblé			Oncologie
74	Parcours traceur		Chirurgie et interventionnel Médecine Hospitalisation complète Adulte Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
75	Traceur ciblé			Dispositif médical réutilisable : Endoscopie
76	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
77	Traceur ciblé			Dispositif médical réutilisable : Endoscopie
78	Patient traceur		Chirurgie et interventionnel Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
79	Patient traceur		Médecine Ambulatoire Enfant et adolescent Patient atteint d'un cancer Programmé Tout l'établissement	

80	Audit système			
81	Parcours traceur		Médecine Hospitalisation complète Patient âgé Patient en situation de handicap Urgences Tout l'établissement	
82	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
83	Parcours traceur		Chirurgie et interventionnel Médecine Ambulatoire Hospitalisation complète Adulte Patient âgé Patient atteint d'un cancer Programmé Tout l'établissement	
84	Parcours traceur		Chirurgie et interventionnel Médecine Hospitalisation complète Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Urgences Tout l'établissement	
85	Traceur ciblé			Prescription intégrant, a minima, un médicament à risque injectable
	Traceur			psc

86	ciblé			
87	Traceur ciblé			PER OP
88	Parcours traceur		Chirurgie et interventionnel Soins critiques Hospitalisation complète Adulte Patient âgé Patient en situation de handicap Urgences Tout l'établissement	
89	Audit système			
90	Audit système			
91	Audit système			
92	Traceur ciblé			médicament injectable douleur
93	Audit système			
94	Traceur ciblé			EI
95	Audit système			

Retrouvez tous nos travaux sur
www.has-sante.fr

